



Collection MedWIZ

6^e année médecine

MÉDECINE D'URGENCE

Wisdom. Innovation. Zeal.

CET OUVRAGE APPARTIENT À

_____ • _____

Nom : _____

Prénom : _____

Université / Faculté : _____

Matricule du BAC : _____

Année universitaire : _____

N° de téléphone : _____

E-mail : _____

AVANT- PROPOS

The WIZ est né d'une ambition simple : rendre la révision plus claire, structurée et efficace.

Chaque ouvrage a été conçu comme un support pédagogique permettant à l'étudiant d'organiser ses connaissances, d'identifier les notions essentielles et d'optimiser son temps de révision.

Pour accompagner cet apprentissage, les ouvrages The WIZ associent :

- Des fiches synthétiques, conçues pour faciliter la compréhension, la mémorisation et la révision des notions essentielles.
- Des espaces « Mes Notes », destinés à compléter et personnaliser le contenu au fil de l'apprentissage.
- Le WIZ Tracker, un outil permettant de suivre sa progression et d'organiser ses révisions de manière méthodique.

NOTE IMPORTANTE



Les ouvrages The WIZ sont des supports de synthèse et de révision. Ils ne se substituent ni aux cours officiels, ni aux ouvrages de référence, ni aux recommandations et sources académiques en vigueur.



Malgré le soin apporté à l'élaboration et à la vérification du contenu, l'étudiant est invité à confronter les informations présentées aux références officielles et actualisées, qui demeurent la source de référence.

WIZ TRACKER

I. Cours :

N°	Intitulé du cours	Page	C01	C02	C03	QCM
01	Organisation du service des urgences	8				
02	Régulation médicale	10				
03	Médecine pré-hospitalière - Aspects organisationnels	14				
04	États de choc	16				
05	Intoxication médicamenteuse aiguë	20				
06	Gestion des afflux massifs de blessés en milieu hospitalier	22				
07	Triage médical aux urgences	24				
08	Médecine de catastrophe	26				
09	Brûlures étendues	28				
10	Urgences hypertensives	30				
11	Arrêt cardio-circulatoire (ACC)	32				
12	Polytraumatisé	34				
13	Oxygénothérapie aux urgences	36				
14	Dysthermies ; Hypothermie et hyperthermie	38				
15	Anaphylaxie	42				
16	Envenimations	46				
17	Brûlures caustiques du tractus digestif supérieur	50				
18	Pathologies circonstanciées : Noyade, électrisation et pendaison	52				

II. Travaux dirigés :

N°	Intitulé du cours	Page	C01	C02	C03	QCM
19	Fièvre aiguë	58				
20	Classification des antibiotiques	62				
21	Dyspnée aiguë	64				
22	Douleurs aiguës	68				
23	Hémorragies aiguës	72				
24	Troubles de la conscience	74				
25	Douleur thoracique aiguë	78				
26	Iatrogénie médicamenteuse	80				
27	Convulsion et état de mal convulsif	84				
28	Traumatisme (Thoracique, abdominal et rachidien)	88				

Partie I

© 2026 The WIZ / Tous droits réservés.

Cours

© 2026 The WIZ. Tous droits réservés.

ORGANISATION DU SERVICE DES URGENCES

I. INTRODUCTION

- Demande croissante de soins d'urgence (progrès techniques, accidents, catastrophes, pathologies modernes)
- Le SU est un carrefour pluridisciplinaire (urgences vitales, psychiatriques, sociales, ambulatoires)
- Particularités : ne choisit pas ses patients, pas de maîtrise de l'amont/aval, doit s'adapter aux flux et capacités d'hospitalisation

II. ORGANISATION ARCHITECTURALE

Objectifs : Accueil → Triage → Diagnostic → Stabilisation → Orientation

Concepts clés :

1. Situation : Visible, accessible, entrée distincte, plain-pied, proche de la radio, bloc opératoire, réanimation et labos
2. Circulations : Flux étrangers interdits, portes motorisées pour brancards
3. Sectorisation : Accueil, soins, technique, service, UHCD
4. Polyvalence : Standardisation pour flexibilité
5. Sécurité : Accès contrôlé aux zones de soins
6. Surveillance/Confidentialité : Équilibre entre visibilité médicale et intimité des patients
7. Informatique : Prévoir avant construction
8. Stockage : Périphérique, chariots de soins (pas de stock en salle de soins)

III. ZONES FONCTIONNELLES

1. Zone d'accueil

- Salle d'attente, accès piétons/ambulances séparés, accueil administratif
- Triage par IOA (infirmier organisateur) avec critères de gravité
- Aires de décontamination

2. Zone d'examen et de soins

- Salles d'examen
- Poste central de soins
- SAUV (Salle d'Accueil des Urgences Vitales) : équipée pour urgences graves (défibrillateurs, respirateurs, monitoring)
- Zones spécifiques : pédiatrie, psychiatrie, suture, plâtre, gynécologie, ORL/ophtalmologie
- Salle de bain/douche, zone d'observation

3. Soins ambulatoires

- Prise en charge de pathologies ne nécessitant pas d'hospitalisation (pansements, injections, consultations spécialisées)

4. Bloc opératoire

- Intervention en urgence avec accès direct depuis le SU

5. Zone technique

- Radiologie contiguë : conventionnelle, scanner, échographie
- Laboratoires : acheminement rapide (pneumatique)

6. Zone de service / personnel

- Vestiaires, salle de détente, réunion, bibliothèque
- Bureaux médicaux, secrétariat
- Archives, office des malades
- Chambres de garde, locaux techniques

7. UHCD (Unité d'Hospitalisation de Courte Durée)

- Durée max : 24h
- Objectifs : retour à domicile ou orientation vers service adapté
- Présence médicale 24h/24

8. Box d'isolement

- Pour maladies contagieuses ou symptômes complexes
- Ventilation spéciale, protection du personnel, désinfection renforcée

IV. DONNÉES TECHNIQUES

Aspect	Exigences / Principes
1. Superficie	Pas de normes fixes, adaptation locale
2. Éclairage	Lumière naturelle privilégiée
3. Signalétique	Visible depuis la ville
4. Ambiance	Matériaux apaisants (couleurs, acoustique)
5. Hygiène	Lavage des mains, salles individuelles, chambre d'isolement
6. Surfaces	Matériaux solides pour usage intensif
7. Température	Contrôle permanent (stores, chauffage, climatisation)

RÉGULATION MÉDICALE (1)

I. DÉFINITION ET CADRE

- Assurer des soins d'urgence adaptés à tout patient, en tout lieu
- AMU assurée par : dispositifs communaux / départementaux de secours + SAMU / CRRA / SMUR + professionnels de santé

II. ORGANISATION

- CRRA : centre de réception et régulation des appels médicaux
- CTA : centre de transmission de l'alerte

Missions du CRRA :

- Réception de tous les appels médicaux
- Centralisation et répartition des demandes de soins
- Interconnexion avec les services d'incendie et secours

III. RÔLE DES ASSISTANTS DE RÉGULATION (ARM)

- Ouverture dossier, localisation, motif, gravité par interrogatoire bref
- Transmission au médecin régulateur
- Pas de décision médicale par les ARM

IV. ACTE DE RÉGULATION (ACTE MÉDICAL)

- Pré-diagnostic orienté vers la gravité potentielle
- Détermination de l'effecteur le mieux adapté
- Déclenchement rapide
- Qualité de communication + notion de contrat avec l'appelant
- Fin de l'acte = choix de la réponse :
 1. UMH (SMUR)
 2. Premier secours / Ambulance
 3. Médecin généraliste
 4. Conseil simple

Règle d'or : Le doute doit être au bénéfice du patient

V. GESTION DES MOYENS

- Équilibre entre réponse aux demandes et risque de pénurie
- Différer les transports non urgents, récuser les transferts limites
- Recours aux départements limitrophes

VI. ORIENTATION HOSPITALIÈRE

Sous responsabilité du médecin régulateur, repose sur :

1. Plateau technique adapté à la pathologie
2. Disponibilité des lits
3. Souhait du patient
4. Suivi du patient
5. Réseaux et secteur
6. Facilité et rapidité d'accès